Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 6ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº 0122537-24.2024.8.17.2001

AUTOR(A): EMANUELA NOGUEIRA DE MELO

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

EMANUELA NOGUEIRA DE MELO, devidamente qualificada, ajuizou a presente **AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS** em face da UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, igualmente qualificada.

Narra a autora, em sua petição inicial (Id. 186507574), ser beneficiária do plano de saúde da ré e portadora de Depressão Resistente ao Tratamento (CID-10: F33.3), com histórico de mais de uma década de tratamentos infrutíferos e risco iminente de suicídio. Alega que, diante da refratariedade de seu quadro, sua médica assistente prescreveu tratamento com o medicamento SPRAVATO (Escetamina Spray Nasal), cuja cobertura foi negada pela ré sob o argumento de não constar no rol da ANS. Sustenta a abusividade da negativa e o consequente agravamento de seu sofrimento.

Frente a esse estado de coisas, requereu, alfim: a) a concessão da tutela de urgência requerida, objetivando que a parte requerida seja compelida a fornecer o medicamento SPRAVATO – Spray Nasal; b) a confirmação da tutela na sentença; c) condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Juntou documentos e pagou as custas.

Após manifestação da parte demandada, a tutela de urgência foi deferida (Id. 188277926).

Em sua contestação (Id. 189507984), a ré arguiu, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa. No mérito, sustentou a legalidade da recusa, afirmando que a autora não preenche os critérios para o diagnóstico de depressão resistente e que o tratamento não possui eficácia comprovada para prevenção de suicídio. Defendeu a taxatividade do rol da ANS e a ausência de ato ilícito.

Requereu a improcedência dos pedidos.

Juntou documentos.

Houve réplica.

Instadas as partes sobre provas a produzir, a demandada pugnou pela realização de audiência de instrução, assim como pela realização de perícia técnica, ao passo que a parte demandante se limitou a atravessar a petição sob Id. 195969912.

No curso do processo, a autora informou intolerância ao medicamento SPRAVATO, apresentando novo laudo médico que prescreveu a sua substituição por CETAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL (Id. 195969912). O juízo, em nova decisão, estendeu os efeitos da tutela para determinar o fornecimento do novo medicamento (Id. 201954977).

Após a comunicação do cumprimento da decisão proferida por este Juízo, vieram-me os autos conclusos.

É o que há para relatar.

DECIDO.

Conheço diretamente do pedido, pois a lide comporta julgamento antecipado, a teor da regra editada no art. 355, inc. I, do NCPC, por desnecessária a dilação probatória, sendo suficiente ao deslinde do litígio a prova documental já produzida.

Quanto ao pedido de audiência de instrução para oitiva da parte autora e produção de prova pericial, é de bom alvitre tecer algumas considerações.

De início, cumpre transcrever o teor do art. 370, do CPC, que assim dispõe:

"*Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.*

Parágrafo único. ***O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias***".

Dentro desse contexto, entendo que as provas requeridas pela demandada em nada servirão para a elucidação da questão posta em Juízo. É que, em nosso entender, o feito já se encontra suficientemente instruído, especialmente pela prova documental colacionada aos autos, em especial os laudos médicos acostados, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução ou de realização de qualquer perícia médica na autora.

Cumpre salientar, como já dito na decisão que deferiu a tutela antecipada em Id. 188277926, que cabe tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o método terapêutico mais adequado para o tratamento do assistido, tendo em vista o acompanhamento clínico contínuo realizado pelo profissional, sob pena de se colocar em risco a vida do consumidor.

Nessa ordem de ideias, a realização de perícia técnica, a fim de se extrair uma segunda opinião médica, ou a realização de audiência de instrução com o fito de ouvir a parte autora em nada desqualificará o diagnóstico e o tratamento indicado à demandante pelo médico que a acompanha, melhor conhecedor de sua condição.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer –Recusa de cobertura de cirurgia buco-maxilo-facial – Procedência – Insurgência - Cerceamento de defesa inexistente – **Desnecessidade da prova pericial - Cirurgia prescrita por médico responsável pelo tratamento do paciente** – Relatórios médicos confirmam a necessidade da cirurgia - Materiais inerentes ao ato - Junta médica ou perícia criada pela Ré não pode estabelecer qual o método mais adequado para tratamento da doença –

Divergência no tocante aos materiais fica superada pela indicação e justificativa adequadas constantes do Relatório Médico - Entendimento jurisprudencial desta C. Câmara - Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10420581320208260224 SP 1042058-13.2020 .8.26.0224, Relator.: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 19/07/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Assim, com fulcro no art. 370, parágrafo único, do CPC, indefiro a produção das provas pleiteadas.

Passo à análise das preliminares aventadas.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A preliminar de impugnação ao valor da causa não merece acolhida.

A parte autora, ao ajuizar a presente demanda, atribuiu à causa o valor de R$ 140.910,00, quantia esta que corresponde à soma do custo estimado do tratamento médico prescrito (R$ 130.910,00) com o valor pleiteado a título de danos morais (R$ 10.000,00), em conformidade com o disposto no art. 292, VI, do Código de Processo Civil.

A parte ré, ao impugnar o valor atribuído, limitou-se a alegar genericamente sua incorreção, sustentando que deveria refletir apenas o pedido de indenização por danos morais, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação do suposto valor real do tratamento ou propor valor alternativo, embora detenha maior aptidão técnica e contratual para quantificar o custo do medicamento objeto da controvérsia, especialmente por ser a operadora do plano de saúde.

Dessa forma, entendo que a impugnação não logrou êxito em demonstrar a inadequação do valor atribuído pela parte autora, o qual, repita-se, foi fundamentado e proporcional ao proveito econômico pretendido.

Preliminar rejeitada.

Estando o feito em ordem, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da lide reside na obrigatoriedade da operadora de saúde em custear o tratamento prescrito à autora para quadro de depressão grave e resistente, bem como na caracterização de dano moral pela recusa inicial.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, como direito básico, a proteção da vida, saúde e segurança do consumidor contra práticas abusivas (art. 6º, I, CDC).

A requerente demonstrou, por meio de farta prova documental, ser portadora de um quadro psiquiátrico grave, crônico e refratário a diversas terapias convencionais. Os laudos médicos carreados aos autos (Id. 186511882 e Id. 187314711), subscritos por profissionais que a acompanham, são uníssonos ao atestar a severidade da condição e o risco iminente à sua vida.

De início, objetivando obter cobertura do medicamento SPRAVATO, a parte autora juntou o laudo médico prescrito pela médica Ana Carla Lopes de Albuquerque, no qual aduz (Id. 186511882):

"*(...) A escetamina corresponde a uma verdadeira mudança de paradigma para o tratamento da depressão grave, resistente ao comportamento suicida pelo rápido inicio de ação (24h) e por possibilitar tratamento em hospital dia onde o paciente faz a aplicação sob supervisão, sempre acompanhado por familiar e retorna para casa cerca de 3 horas após a aplicação, evitando custo financeiro, social e emocional de um internamento psiquiátrico prolongado.* ***O tratamento solicitado com escetamina spray nasal, espera-se rápida redução da sintomatologia, já em 4 horas após a primeira aplicação, sendo a única droga já aprovada com esse desfecho, reduzindo consideravelmente os sintomas depressivos e a ideação suicida.***

(...)

Por todo o exposto acima, conclui-se ser de extrema urgência a liberação da escetamina spray nasal em regime de hospital dia, para o paciente em questão, ***por ser o tratamento clinico mais adequado para o caso apresentado, no sentido de promover melhora dos sintomas e qualidade de vida para alguém que sofre com essa enfermidade por tantos anos***".

Posteriormente, diante da intolerância da autora ao SPRAVATO, a mesma médica assistente indicou a substituição da terapia pela CETAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL, conforme consta do documento de Id. 195969914, igualmente fundamentado, que aponta a persistência da gravidade do quadro depressivo e reforça o risco iminente de suicídio. Transcrevo trecho do laudo firmado:

"*(...) Apesar da aprovação da escetamina em bula ser na forma de administração em spray nasal, paciente refere muitos efeitos adversos como prejuízo em sono e piora da ansiedade de forma que não tolera a continuidade do tratamento proposto. Todavia, ja foi tentado uso da cetamina solução injetável pela paciente, com boa tolerância e resposta antidepressiva.* ***Atualmente há vários estudos comprovando a eficácia e segurança da cetamina solução injetável. Resolução do conselho Federal de Medicina reconhece a cetamina uma ferramenta valiosa no tratamento da depressão e orienta o uso da cetamina solução injetável de forma criteriosa com especialista formado*** *(...)*".

Ressalte-se que a ANVISA, através da Resolução-RE nº 4.413, de 29 de outubro de 2020, aprovou sua administração na forma de spray nasal do cloridrato de escetamina (Spravato) no tratamento de depressão refratária.

O spray nasal de Spravato é indicado para pacientes resistentes a dois tratamentos prévios de depressão unipolar e para pacientes em risco iminente de suicídio.

No site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/spravato-r-cloridrato-de-escetamina-novo-registo (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/spravato-r-cloridrato-de-escetamina-novo-registo)) consta registrado como medicamento novo, com a seguinte indicação:

"SPRAVATO® é indicado ***para Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave*** *(depressão resistente ao tratamento) em combinação com antidepressivos orais (tais como ISRS – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ISRSN – Inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina).*

SPRAVATO® é indicado, em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda".

Quanto ao uso da cetamina injetável, diversos são os estudos que direcionam sua efetividade ao tratamento de DRT (Depressão Resistente ao Tratamento) [1] (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/movimentar.seam?newTaskId=5834200367&idProcesso=6612504&edicao=true&iframe=true#_ftn1)[2] (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/movimentar.seam?newTaskId=5834200367&idProcesso=6612504&edicao=true&iframe=true#_ftn2)[3] (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/movimentar.seam?newTaskId=5834200367&idProcesso=6612504&edicao=true&iframe=true#_ftn3).

Em razão disso, a jurisprudência nacional, em geral, posiciona-se favorável ao seu deferimento, especialmente quando negados abusivamente pelos planos de saúde, senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Negativa de custeio de sessões de infusões de Cetamina para tratamento de Depressão Grave – Alegação de ausência de previsão no rol de procedimentos/diretrizes de utilização da ANS – Recusa Indevida – Violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato – Taxatividade do rol da ANS que não é absoluta – Atribuição do profissional escolhido pela paciente estabelecer qual o método mais adequado para o tratamento da doença. – Hipótese em que não foi demonstrado haver atualização do rol ou contraindicação ao tratamento de eficácia notória – Súmulas 95 e 102 do TJSP – Dano moral in re ipsa – Indenização devida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1052498-81.2022 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 09/05/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CETAMINA . TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE. RECUSA COM BASE NO ROL DA ANS. ILEGITIMIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA . TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 .Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde forneça ou custeie o medicamento "Cetamina", conforme prescrição médica de paciente diagnosticada com depressão grave e resistente a tratamentos anteriores. A agravante sustenta a ausência de cobertura contratual e a exclusão do medicamento do rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 .Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura do medicamento "Cetamina" pelo plano de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS, é legítima; e (ii) analisar a necessidade de manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Embora o rol da ANS estabeleça parâmetros mínimos de cobertura, a recusa do tratamento prescrito pelo médico assistente com base na ausência de previsão no rol não é legítima, quando comprovada a necessidade terapêutica e a gravidade da doença . 4.A autora, segurada do plano de saúde da agravante, apresenta quadro de depressão grave (CID-10 F33.2), resistente a tratamentos anteriores, como a eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética, conforme relatório médico. 5 .O médico assistente indicou o uso de Cetamina como alternativa para o tratamento, justificando a imprescindibilidade do fármaco diante do quadro clínico da paciente. 6.A recusa do fornecimento de medicamento prescrito para administração em ambiente clínico, sob supervisão médica, não encontra amparo na exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9 .656/98, que trata da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. 7.A negativa de cobertura não foi b aseada em justificativa técnica relacionada à ineficácia ou inadequação do tratamento, mas apenas na ausência de previsão contratual e no rol da ANS, o que não é suficiente para afastar o direito da segurada ao tratamento necessário. 8 .Em cognição sumária, a

decisão de deferir a tutela de urgência se mostra adequada, considerando a gravidade do quadro clínico e a necessidade do tratamento, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.A negativa de cobertura de medicamento fora do rol da ANS não é legítima, quando há expressa indicação médica que justifica a imprescindibilidade do tratamento, especialmente em casos de doenças graves e resistentes a tratamentos convencionais. 2.A recusa de fornecimento de medicamento de administração clínica, sob supervisão médica, não se enquadra na exclusão de cobertura prevista para medicamentos de uso domiciliar pelo art . 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art . 10, VI; CR/1988, art. 196. V.v: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL . PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigá-la a fornecer medicamento não previsto no contrato, pleiteado pela autora, portadora de Transtorno Depressivo Recorrente em episódio grave sem sintomas psicóticos (CID 10 - F33 .2). A agravante alega que a medicação não está incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme cláusulas contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui o medicamento pleiteado da cobertura do plano de saúde é válida; (ii) verificar se a tutela de urgência concedida na instância inferior deve ser mantida, diante da alegada inexistência dos

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35764448920248130000, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

Nesse cenário, a recusa da ré, pautada na ausência do tratamento no rol da ANS, não se sustenta. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, pacificou o entendimento de que a cobertura de tratamentos não inclusos no rol pode ser obrigatória, desde que haja, entre outras hipóteses, comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, que é o caso dos medicamentos requeridos nos autos, como já demonstrado.

Cumpre salientar que os medicamentos aqui requeridos não foram indicados como primeira linha terapêutica. Pelo que se depreende da análise do acervo probatório produzido, suas prescrições decorreram de um longo e penoso histórico clínico de insucesso terapêutico, em que a autora, ao longo de mais de uma década, submeteu-se a diversas abordagens medicamentosas e não medicamentosas sem alcançar resultados satisfatórios no controle do transtorno depressivo grave que a acomete.

Em conclusão, no caso dos autos, a indicação terapêutica para melhoria do estado de saúde do paciente compete ao médico, pois é ele que tem condições para apurar as verdadeiras condições de saúde do doente.

Não vejo, pois, como negar ao paciente o fornecimento de medicamentos necessários à melhora da sua moléstia, a fim de poder tratá-la e melhorar sua qualidade de vida, bem maior amparado pela carta Magna e principal objetivo do contrato celebrado.

Ao atuar de tal forma, a demandada ofende os princípios constitucionais relacionados à proteção da saúde e da dignidade da pessoa humana, além de concretizar conduta abusiva ao desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde, caracterizando conduta abusiva e contrária à boa-fé, nos termos que dispõe o art. 51, IV, do CDC.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, observo que se trata de indenização decorrente de danos presumidos, que prescindem in re ipsa de culpa, bastando a atitude ilícita do fornecedor – pois estamos diante de uma relação consumerista – e nexo causal entre a conduta e tal ato. Destaque-se que os fatos evidenciam verdadeiro abalo emocional, no mínimo piorado pelo comportamento da operadora/ré, que protelou a prestação de seu serviço de saúde, elevando a falha na prestação de seu serviço, configurando, portanto, dano moral indenizável.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica de ambas as partes, para assegurar a justa reparação pelos danos sofridos, sem que ocorra enriquecimento ilícito e garantindo efeito pedagógico para que conduta similar não se repita, fixo o valor indenizatório na quantia certa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por EMANUELA NOGUEIRA DE MELO em face de UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, para:

a) **CONFIRMAR** a tutela de urgência estendida pela decisão de Id. 201954977, para CONDENAR a ré na obrigação de fazer consistente em custear o tratamento da autora com o medicamento CETAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL, enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de manutenção da multa já fixada;

b) **CONDENAR** a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor esse que tenho por bom e suficiente à mitigação da situação angustiante e sofrimento experimentados, com correção monetária a contar da data desta sentença, nos termos da Súmula 362, do STJ e do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora, a partir da citação, contabilizados de acordo com a SELIC (CC, art. 405 e CPC, art. 240), deduzindo o índice de atualização monetária quando houver sobreposição, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Por fim, constatada a hipótese do art. 487, I, do vigente Estatuto de Ritos, resolvo o mérito do feito por sentença, imputando à operadora promovida o ônus da sucumbência, representado pelas custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor total da condenação financeira + obrigação de fazer (art. 85, §2º, CPC/2015).

Independentemente de nova intimação, a parte ré deverá comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais após quinze (15) dias úteis do trânsito em julgado, sob pena de que se oficie ao Comitê Gestor de Arrecadação do TJPE (ou quem lhe faça as vezes) para adoção das providências de cobrança cabíveis, incluindo a multa de 20%, na forma dos arts. 22, 27, §3º, da nova Lei de Custas (Lei Estadual nº 17.116/2020).

Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Recife-PE, data digitalmente certificada.

Ana Paula Costa de Almeida

Juíza de direito em exercício

ds

[1] (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/movimentar.seam?newTaskId=5834200367&idProcesso=6612504&edicao=true&iframe=true#_ftnref1) https://doi.org/10.1590/0047-2085000000371

[2] (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/movimentar.seam?newTaskId=5834200367&idProcesso=6612504&edicao=true&iframe=true#_ftnref2) https://abeso.org.br/cetamina-a-droga-que-esta-sendo-usada-para-tratar-a-depressao/ (https://abeso.org.br/cetamina-a-droga-que-esta-sendo-usada-para-tratar-a-depressao/)

[3] (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/movimentar.seam?newTaskId=5834200367&idProcesso=6612504&edicao=true&iframe=true#_ftnref3) https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huol-ufrn/comunicacao/noticias/entenda-como-a-cetamina-pode-ser-usada-em-tratamento-de-depressao-severa

Assinado eletronicamente por: ANA PAULA COSTA DE ALMEIDA
11/07/2025 19:43:57
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 209411988

25071119435770100000203912612

IMPRIMIR GERAR PDF